ESTUDO DE CASO – 5

Maria de Jesus e a construção do diagnóstico

1. Como o caso de Maria de Jesus permite refletir sobre a construção histórica do conceito de loucura?

Resposta:

O caso de Maria de Jesus mostra que, historicamente, o conceito de loucura não foi construído apenas a partir de critérios clínicos. A internação de uma jovem de 23 anos por apresentar tristeza evidencia como manifestações de sofrimento poderiam ser interpretadas como motivo para afastamento e institucionalização. Além disso, o Hospital Colônia recebia pessoas por diferentes razões, inclusive sem diagnóstico de doença mental. Assim, o caso permite compreender que fatores sociais e culturais influenciaram a definição de quem deveria ser institucionalizado. A perspectiva atual valoriza a avaliação individual, a escuta e o cuidado em liberdade, evitando transformar sofrimento psíquico em motivo automático de exclusão.

2. Qual a relação entre diagnóstico, estigma e institucionalização no contexto apresentado?

Resposta:

No contexto apresentado, o diagnóstico ou a atribuição de uma condição de saúde mental podia reforçar o estigma e justificar o afastamento da pessoa da família e da sociedade. Quando o sofrimento era interpretado de forma limitada e associado à incapacidade, a institucionalização podia se tornar uma resposta de exclusão. O caso evidencia, portanto, que diagnóstico sem avaliação adequada e sem respeito à singularidade pode contribuir para a perda de autonomia e para a marginalização. Atualmente, o diagnóstico deve orientar o cuidado, e não definir o valor ou a identidade da pessoa.

3. Quais consequências podem ocorrer quando o sofrimento psíquico é compreendido exclusivamente a partir da exclusão e do isolamento?

Resposta:

A exclusão e o isolamento podem provocar perda de vínculos familiares e sociais, redução da autonomia, sofrimento adicional, dependência institucional e dificuldades de reinserção comunitária. Também podem favorecer a manutenção do estigma, pois a pessoa deixa de ser reconhecida em sua individualidade e passa a ser vista principalmente pelo sofrimento que apresenta. O caso de Maria de Jesus demonstra a importância de substituir respostas baseadas no afastamento por estratégias de cuidado que preservem direitos, vínculos e participação social.

4. Como a Enfermagem deve atuar atualmente diante de uma pessoa em sofrimento psíquico, considerando os princípios da atenção psicossocial?

Resposta:

A Enfermagem deve oferecer acolhimento, escuta qualificada, respeito à dignidade e avaliação individualizada. O profissional deve identificar necessidades de cuidado, estimular a autonomia, fortalecer vínculos familiares e sociais e trabalhar de forma integrada com a equipe multiprofissional. Também deve evitar atitudes discriminatórias e práticas desnecessariamente coercitivas, valorizando o cuidado em liberdade e a participação do usuário nas decisões. O plano de ação deve incluir acompanhamento contínuo, educação em saúde, identificação de fatores de risco e proteção e articulação com os serviços da rede de atenção psicossocial.

Plano de ação de Enfermagem

Plano de ação: realizar acolhimento e escuta qualificada; avaliar necessidades e condições de sofrimento; construir, com a pessoa, um plano de cuidados individualizado; preservar autonomia e dignidade; fortalecer vínculos familiares e comunitários; orientar sobre os serviços disponíveis na rede de atenção psicossocial; acompanhar a evolução do caso e registrar as intervenções; promover educação em saúde para reduzir estigma e incentivar a busca de cuidado quando necessário.

ESTUDO DE CASO – 06

Conceição Machado: institucionalização e resistência

1. Que elementos do caso evidenciam a relação entre institucionalização, poder e perda de autonomia?

Resposta:

A institucionalização aparece relacionada ao controle da vida cotidiana de Conceição, que foi internada aos 15 anos e submetida às condições impostas pela instituição. A permanência em um ambiente no qual alimentação, assistência e cuidado eram determinados institucionalmente reduzia sua possibilidade de decidir sobre a própria vida. O isolamento em uma pequena cela como forma de punição evidencia o uso do poder para controlar comportamentos e silenciar reivindicações. Dessa forma, o caso mostra como a institucionalização pode produzir perda de autonomia quando o usuário não participa das decisões sobre seu próprio cuidado.

2. Como a resistência de Conceição pode ser compreendida na perspectiva dos direitos das pessoas em sofrimento psíquico?

Resposta:

A resistência de Conceição pode ser compreendida como uma manifestação de defesa da dignidade e dos direitos humanos. Ao reivindicar melhores condições de alimentação, assistência e cuidado, ela demonstrou que a pessoa institucionalizada continua sendo sujeito de direitos. Sua atitude reforça a necessidade de escutar o usuário e reconhecer sua capacidade de expressar necessidades e participar das decisões. O cuidado em saúde mental deve respeitar liberdade, dignidade, autonomia e proteção contra práticas degradantes.

3. Quais diferenças podem ser identificadas entre uma prática baseada na punição e uma prática baseada no cuidado?

Resposta:

A prática baseada na punição utiliza controle, isolamento e restrição como respostas ao comportamento considerado inadequado. Já a prática baseada no cuidado procura compreender as necessidades da pessoa, oferecer escuta, acolhimento e suporte e construir estratégias terapêuticas individualizadas. No primeiro modelo, a pessoa tende a perder autonomia; no segundo, busca-se fortalecê-la. O caso de Conceição evidencia que o cuidado humanizado deve substituir medidas de punição por intervenções que respeitem direitos e promovam participação.

4. Qual deve ser o papel da Enfermagem na defesa da autonomia e da dignidade da pessoa em sofrimento psíquico?

Resposta:

A Enfermagem deve atuar como parte da equipe responsável por garantir cuidado seguro, humanizado e respeitoso. Cabe ao profissional ouvir o usuário, reconhecer suas necessidades, incentivar sua participação nas decisões, preservar sua privacidade e defender seus direitos. Também é importante identificar e comunicar situações que possam representar violação da dignidade, evitando práticas coercitivas sem justificativa clínica. O plano de cuidado deve estimular autonomia, vínculos, autocuidado e participação social, com acompanhamento contínuo.

Plano de ação de Enfermagem

Plano de ação: acolher Conceição de maneira respeitosa; avaliar suas necessidades físicas, emocionais e sociais; garantir escuta e participação nas decisões; identificar situações de violação de direitos; evitar punições e práticas de isolamento injustificadas; estimular atividades terapêuticas e de convivência; fortalecer vínculos familiares e comunitários; trabalhar com a equipe multiprofissional; registrar e acompanhar as intervenções; promover educação em saúde e defesa da dignidade.

ESTUDO DE CASO – 07

Antônio Gomes da Silva: quando a instituição apaga a identidade

1. Como o caso de Antônio evidencia os efeitos da institucionalização prolongada sobre autonomia e identidade?

Resposta:

O caso evidencia que a institucionalização prolongada pode reduzir oportunidades de expressão, escolha e convivência, contribuindo para a perda de autonomia e para o apagamento da identidade. Antônio permaneceu longos períodos sem comunicação verbal e chegou a ser considerado mudo, embora posteriormente se descobrisse que falava e sabia escrever o próprio nome. Isso demonstra a importância de não definir a pessoa apenas pela aparência de seu comportamento institucionalizado. A saída para uma residência terapêutica representou uma possibilidade de reconstrução de autonomia e vida comunitária.

2. Qual a importância da comunicação e da escuta no cuidado em Saúde Mental?

Resposta:

A comunicação e a escuta são fundamentais para conhecer desejos, necessidades, sentimentos e capacidades do usuário. No caso de Antônio, a descoberta de que ele falava e escrevia seu nome demonstra que a ausência de comunicação verbal observada durante a institucionalização não deveria ter sido interpretada como incapacidade definitiva. A escuta qualificada permite reconhecer a pessoa em sua singularidade, estabelecer vínculo terapêutico e favorecer sua participação no próprio cuidado.

3. Por que a convivência comunitária é importante para a reabilitação psicossocial?

Resposta:

A convivência comunitária favorece a reconstrução de vínculos, o exercício da autonomia, a participação social e o desenvolvimento de atividades da vida cotidiana. Para pessoas que passaram longos períodos institucionalizadas, o contato com a comunidade pode contribuir para recuperar papéis sociais e fortalecer a identidade. A residência terapêutica, apresentada no caso, representa uma alternativa que possibilita viver fora do ambiente institucional e participar da vida comunitária com suporte.

4. Elabore um plano de ação de Enfermagem que favoreça autonomia, comunicação, vínculos sociais e participação do usuário no próprio cuidado.

Resposta:

O plano de ação deve começar com acolhimento, escuta e avaliação individual das capacidades e necessidades de Antônio. A equipe de Enfermagem deve estimular formas de comunicação verbal e escrita, respeitando seu ritmo e suas preferências. Deve também incentivar atividades de autocuidado e decisões simples do cotidiano, aumentando gradualmente sua autonomia. É importante favorecer contato com familiares e comunidade, participação em atividades terapêuticas e sociais e acompanhamento multiprofissional. O usuário deve ser incluído na elaboração e avaliação do plano de cuidados, para que suas escolhas sejam respeitadas.

Plano de ação de Enfermagem

Plano de ação: realizar avaliação integral e escuta qualificada; identificar formas de comunicação que Antônio utilize com facilidade; estimular expressão verbal e escrita; incentivar autocuidado e escolhas cotidianas; fortalecer vínculos familiares e sociais; favorecer participação em atividades comunitárias e

terapêuticas; acompanhar a adaptação à residência terapêutica; trabalhar com a equipe multiprofissional; registrar evolução e reavaliar o plano de cuidados periodicamente.